Resumos de Pediatria

Batistaz

Caderno de Estudos · Gastroenterologia

Diarreia Aguda e Desidratação

Planos A, B e C

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Sumário

Diarreia aguda e desidratação · planos A, B e C

I É diarreia aguda? 3
Definição, agentes, persistente e o que mais pode ser

II A criança está desidratada? 4
O quadro de avaliação do Ministério da Saúde

III Plano A: tratar em casa 5
Líquidos, alimentação, zinco e sinais de alerta

IV Plano B: reidratar no serviço 6
SRO, ondansetrona, gastróclise e as 6 horas

V Plano C: desidratação grave 7
Expansão por idade, manutenção, reposição e potássio

VI Tem sangue: antibiótico? 9
Disenteria, azitromicina, ceftriaxona e reavaliação

VII O que mais prescrever e o que não 10
Antiparasitário, probiótico, racecadotrila, antidiarreico

VIII O que mudou e onde as diretrizes divergem 11
MS antigo × atual, OMS 2024, NICE

IX Mapa de decisão e pegadinhas 12

X Questões de estudo 13

— Gabarito, fontes e anotações 14

Como ler este caderno

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O que fazer no plantão, em ordem.

Atenção
Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

As chaves entre colchetes indicam a fonte de cada dado: [MS] cartaz atual "Manejo do paciente com diarreia" do Ministério da Saúde, [MS-ANT] versão anterior do cartaz, [SBP] guia de diarreia aguda infecciosa (2023), [OMS] pneumonia e diarreia até 10 anos (2024), [NICE] CG84, [AIDPI]. Lista completa no fim.

Capítulo I

É diarreia aguda?

*Diarreia aguda: mudança do hábito intestinal, com **três ou mais evacuações** amolecidas ou líquidas por dia, autolimitada, com duração de **até 14 dias** [SBP]. O lactente em aleitamento exclusivo pode ter fezes frequentes e semilíquidas, com bom ganho de peso: é fisiológico [SBP]. O que mata é a desidratação.*

Tabela 1 · *Pela duração e pelo aspecto*

Aguda	Até 14 dias
Persistente	Mais de 14 dias: menor de 6 meses ou desidratado vai ao hospital (reidratar antes); maior de 6 meses sem desidratação, consulta para investigar [MS]
Crônica	Mais de 30 dias [SBP]
Disenteria	**Sangue nas fezes** (capítulo VI)

Agentes

O **rotavírus** é a principal causa de diarreia grave em menores de 5 anos no mundo; a vacina reduziu de forma relevante as internações onde foi introduzida [SBP]. Também causam diarreia norovírus, adenovírus, bactérias (*E. coli*, *Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter*) e parasitas (*Giardia*, *Entamoeba*).

Exames

Não nos quadros leves. Nos moderados de difícil manejo ou graves: ionograma, gasometria, leucograma e exame de fezes (leucócitos, sangue, parasitas, substâncias redutoras), de preferência colhidos depois da expansão, porque a desidratação distorce os resultados. Coprocultura e pesquisa de vírus para a etiologia, quando muda a conduta, e nos surtos (vigilância) [SBP].

Atenção · febre alta junto com diarreia

Temperatura de **39 °C ou mais**: investigar e tratar outras causas, como pneumonia, otite, amigdalite, faringite e **infecção urinária** [MS]; abaixo de 3 meses, o alerta é **38 °C**. Vômito bilioso, dor intensa ou localizada, distensão, rigidez de nuca, fontanela abaulada ou exantema que não some à pressão sugerem outro diagnóstico [NICE]. Diarreia com vômitos pode ser só o começo de outra doença.

Conduta · as quatro perguntas do cartaz do MS

- Qual o estado de hidratação? (capítulo II)
- Tem sangue nas fezes? (disenteria)
- Há quanto tempo? (mais de 14 dias: persistente)
- Há desnutrição grave? Febre ≥ 39 °C? [MS]

Capítulo II

A criança está desidratada?

Tabela 2 · *Avaliação do estado de hidratação (MS)*

	A · sem desidratação	B · com desidratação	C · desidratação grave
Observe			
Estado geral	Ativo, alerta	Irritado, intranquilo	Comatoso, hipotônico, letárgico ou inconsciente*
Olhos	Sem alteração	Fundos	Fundos
Sede	Sem sede	Sedento, bebe rápido e avidamente	Não é capaz de beber*
Lágrimas	Presentes	Ausentes	Ausentes
Boca e língua	Úmidas	Secas ou levemente secas	Muito secas
Explore			
Prega abdominal	Desaparece imediatamente	Desaparece lentamente	Muito lentamente (> 2 s)
Pulso	Cheio	Cheio	Fraco ou ausente*
Perda de peso	Sem perda	Até 10%	Acima de 10%
Decida			
Classificação	Sem sinais: **Plano A**	≥ 2 sinais: **Plano B**	≥ 2 sinais, **ao menos um com *: Plano C**

[MS]. Estado geral, olhos, sede e prega são as variáveis de melhor sensibilidade e especificidade segundo a OMS. A perda de peso é avaliada no paciente internado com diarreia e vômitos. Na dúvida entre duas classificações, tratar pelo pior cenário.

Cai na prova · os quatro sinais com asterisco

Comatoso, hipotônico, letárgico ou inconsciente · **não consegue beber** · **pulso fraco ou ausente** · (e a prega muito lenta compõe o quadro). Desidratação grave exige dois sinais, sendo pelo menos um desses com asterisco [MS].

Atenção · o que mudou no quadro

O cartaz atual acrescentou **boca e língua** e **perda de peso** à avaliação e mudou o **pulso** do Plano B (de "rápido, fraco" para "cheio"); o guia da SBP de 2023 destaca a valorização dos sinais de desidratação e do pulso no Plano B [MS] [SBP].

Capítulo III

Plano A: tratar em casa

Para prevenir a desidratação e a desnutrição: mais líquido, mesma comida, zinco e sinais de alerta [MS].

Líquidos

- Líquidos caseiros (água, chá, suco, água de coco, sopa) ou **SRO** depois de cada evacuação e vômito, pouco de cada vez e mais vezes.
- **Não** refrigerante; preferir não adoçar chá ou suco.
- Em aleitamento exclusivo, o único líquido além do leite materno é a SRO [MS].

Tabela 3 · *Depois de cada evacuação*

Menor de 1 ano	50–100 mL
1 a 10 anos	100–200 mL
Maior de 10 anos	O que aceitar

[MS]

Alimentação

Manter a **alimentação habitual**, criança e adulto; manter o aleitamento [MS].

Zinco (menores de 5 anos)

1 vez ao dia, por **10 a 14 dias**: até 6 meses, **10 mg/dia**; acima de 6 meses e abaixo de 5 anos, **20 mg/dia** [MS].

Voltar já se

Piora da diarreia (mais vezes ou mais volume) · vômitos repetidos · **sangue nas fezes** · urina diminuída · muita sede · recusa alimentar · não melhorar em 2 dias [MS].

Conduta · ensinar antes de liberar

- Reconhecer os sinais de desidratação e de alerta.
- Preparar e oferecer a SRO.
- Higiene: lavar as mãos, tratar a água em casa, higienizar os alimentos [MS].

Cai na prova · dieta

Não suspender o leite nem fazer dieta restritiva prolongada: manter a alimentação habitual previne a desnutrição [MS] [SBP].

Capítulo IV

Plano B: reidratar no serviço

*Desidratação sem sinal de gravidade: **reidratação oral no estabelecimento de saúde**, até a reidratação completa [MS].*

Tabela 4 · *Plano B*

SRO	Como orientação inicial, **50–100 mL/kg** (média de **75 mL/kg**) em **4–6 horas**; a quantidade depende da sede; oferecer continuamente até sumirem os sinais de desidratação
Vômitos persistentes	Uma dose de **ondansetrona**: 6 meses a 2 anos, 2 mg (0,2–0,4 mg/kg); mais de 2 a 10 anos (até 30 kg), 4 mg; mais de 10 anos (acima de 30 kg), 8 mg
Reavaliar	Pelo quadro de hidratação: sem sinais, Plano A; ainda desidratado, **gastróclise** (sonda nasogástrica); piorou para grave, Plano C
Sem melhora em 6 h	Encaminhar ao hospital de referência para internação

[MS]. Ondansetrona: alerta da Anvisa para não usar em gestantes; avaliar com cautela em lactentes [MS] [SBP].

Cai na prova · o antiemético entrou

O cartaz antigo dizia "antidiarreicos e antieméticos não devem ser usados" [MS-ant]. O atual inclui **ondansetrona em dose única** no Plano B, só se vômitos persistentes, para permitir a reidratação oral [MS].

Conduta · roteiro do Plano B

- Pesar; calcular 75 mL/kg como meta inicial para 4–6 h.
- Oferecer SRO em pequenas quantidades, com colher ou copo, de forma contínua.
- Vômitos persistentes: ondansetrona pela faixa de idade e peso.
- Reavaliar periodicamente; continua desidratado: gastróclise; não melhorou em 6 h: internar.
- Enquanto isso, ensinar a família (SRO, sinais, higiene) [MS].

Atenção · antes da veia, a sonda

Quando a criança segue desidratada no Plano B, o passo seguinte é a **gastróclise** [MS]. A veia entra se evoluir para desidratação grave, se a via oral ou a sonda falharem (vômitos persistentes), se houver piora ou alteração do sensório [SBP] [NICE].

Capítulo V

Plano C: desidratação grave

*Reidratação **endovenosa** no serviço ou hospital, em duas fases: **expansão** e **manutenção com reposição** [MS].*

Tabela 5 · *Expansão: menores de 1 ano*

Etapa	Volume	Tempo
1º	30 mL/kg	**1 hora**
2º	70 mL/kg	**5 horas**

SF 0,9% ou Ringer lactato [MS]

Tabela 6 · *Expansão: a partir de 1 ano*

Etapa	Volume	Tempo
1º	30 mL/kg	**30 min**
2º	70 mL/kg	**2 h 30 min**

SF 0,9% ou Ringer lactato [MS]

Recém-nascido ou menor de 5 anos com **cardiopatia grave**: começar com **10 mL/kg** [MS].

Tabela 7 · *Manutenção e reposição (todas as idades), em 24 h*

Manutenção *SG 5% + SF 0,9% na proporção* ***4:1***	Até 10 kg: **100 mL/kg** · 10 a 20 kg: 1.000 mL + 50 mL/kg do que passar de 10 kg · acima de 20 kg: 1.500 mL + 20 mL/kg do que passar de 20 kg (máx. 2.000 mL)
Reposição *SG 5% + SF 0,9% na proporção* ***1:1***	Iniciar com **50 mL/kg/dia**; reavaliar conforme as perdas
Potássio	KCl 10%: **2 mL para cada 100 mL** da solução de manutenção, depois de conhecer o potássio e a função renal [MS] [NICE]

[MS]

Atenção · o que o cartaz não diz

- **Choque** (enchimento lento, extremidades frias, pulsos fracos, consciência alterada) não é só "desidratação grave": bolus de 10 mL/kg em menos de 10 min e reavaliar; depois, corrigir o déficit [NICE-L].
- **Hipernatremia**: dosar sódio em quem vai para a veia; se alta, corrigir o déficit devagar (em geral 48 h), baixando o sódio menos de 0,5 mmol/L por hora, com especialista [NICE].
- **Controles**: peso diário, entradas e saídas, eletrólitos e glicemia ao iniciar e pelo menos a cada 24 h [NICE-L]. O NICE prefere manutenção isotônica (sódio 131–154 mmol/L); a mistura 4:1 é a do cartaz [NICE-L] [MS].

Conduta · durante e depois

- Avaliar continuamente; sem melhora, aumentar a velocidade de infusão.
- Iniciar SRO **junto** com a veia quando a criança puder beber, em geral 2–3 h depois do início.
- Suspender a veia só quando a SRO mantiver a hidratação; observar **pelo menos 6 horas**; reclassificar (A, B ou continuar C) [MS].

Exemplo de cálculo

Lactente de 8 meses, 7 kg, desidratação grave

- **Expansão** (menor de 1 ano): 30 mL/kg = **210 mL em 1 h**; depois 70 mL/kg = **490 mL em 5 h**.
- **Manutenção** (24 h): 100 mL/kg = 700 mL de SG 5% + SF 0,9% 4:1 (560 mL SG + 140 mL SF), com KCl 10% 14 mL.
- **Reposição** inicial: 50 mL/kg/dia = 350 mL em 24 h de SG 5% + SF 0,9% 1:1, ajustada às perdas [MS].

Atenção · Plano C mudou

No cartaz antigo, a fase rápida para **menores de 5 anos** era SF **20 mL/kg** em 30 min, repetido até hidratar; a de 30 + 70 mL/kg era para maiores de 5 anos [MS-ANT]. O atual divide por **1 ano**: abaixo, 30 mL/kg em 1 h + 70 mL/kg em 5 h; a partir de 1 ano, 30 mL/kg em 30 min + 70 mL/kg em 2 h 30 min [MS]. A tabela do guia SBP 2023 imprime 10 mL/kg em 30 min nessa faixa, divergindo do cartaz [SBP].

Cai na prova · choque não é só Plano C

O Plano C é a hidratação da desidratação grave da diarreia. Criança em choque séptico ou cardiogênico segue outra lógica (bolus reavaliando a cada um); ver o caderno de choque. Na gastroenterite com choque, o NICE dava 20 mL/kg de SF 0,9% [NICE]; desde 2022 usa bolus de **10 mL/kg** [NICE-L].

Desnutrição grave

Desnutrido grave **hidratado**: encaminhar para tratamento. **Desidratado**: iniciar a reidratação imediatamente e depois encaminhar, com SRO suficiente para continuar no caminho [MS]. Na desnutrição grave os sinais de desidratação enganam e superestimar o déficit causa sobrecarga: protocolo próprio e reavaliação frequente [SBP]. Criança desnutrida com disenteria: primeiro atendimento em qualquer serviço, com hidratação e antibiótico imediatos até chegar ao hospital [MS].

Capítulo VI

Tem sangue: antibiótico?

*Antibiótico só em **disenteria com comprometimento do estado geral** (desidratação, febre alta persistente, dor abdominal, tenesmo ou comprometimento sistêmico) ou em cólera grave. Nas outras diarreias, é ineficaz e gera resistência [MS].*

Tabela 8 · *Disenteria com comprometimento do estado geral*

Quem	Esquema
***Até 30 kg (até 10 anos)**, a partir de 3 meses, sem imunodeficiência*	**Azitromicina** VO: **10 mg/kg** no 1º dia e **5 mg/kg/dia** por mais 4 dias. Alternativa: ceftriaxona 50 mg/kg IM 1×/dia, 3–5 dias
Mais de 30 kg (mais de 10 anos), adolescente	Ciprofloxacino 500 mg VO de 12/12 h, 3 dias. Alternativa: ceftriaxona 50–100 mg/kg IM 1×/dia, 3–5 dias
Menor de 3 meses ou imunodeficiente	Ceftriaxona 50–100 mg/kg EV 1×/dia; fora do hospital, 1ª dose IM e referenciar

[MS]. E sempre: reidratar pelo plano adequado, mais líquidos, alimentação habitual.

Conduta · reavaliar em 2 dias

- Sangue persistente depois de 48 h de tratamento, **criança até 10 anos**: **internar**.
- Acima de 10 anos: bem, seguir só os planos de hidratação, sem antibiótico; comprometido, ceftriaxona ou internar [MS].

Cai na prova · ciprofloxacino saiu da criança pequena

O cartaz antigo usava ciprofloxacino 15 mg/kg de 12/12 h por 3 dias na criança [MS-ant]. O atual usa **azitromicina** até 30 kg (10 anos) e reserva o ciprofloxacino acima disso [MS] [SBP]. A OMS (2024) ainda cita ciprofloxacino como 1ª escolha na diarreia com sangue [OMS].

Atenção · diarreia aquosa não leva antibiótico

A OMS também sugere **não** usar antibiótico na diarreia aquosa aguda, recomendação que exclui a cólera [OMS]; o cartaz trata a **cólera grave** [MS]. Disenteria em bom estado geral, pelo cartaz, não entra nos critérios de antibiótico [MS].

Capítulo VII

O que mais prescrever e o que não

Tabela 9 · *Medicamentos na diarreia*

Medicamento	Veredito	Detalhe
Zinco	Sim, < 5 anos	10 mg/dia até 6 meses; 20 mg/dia de > 6 meses a < 5 anos; 10–14 dias [MS]
Ondansetrona	Só vômito persistente no Plano B	Dose única pela idade e peso (capítulo IV) [MS]
Antidiarreico	**Não**	Não devem ser usados [MS] [NICE]
Metronidazol: amebíase	Só com indicação	Falha do tratamento da *Shigella* ou trofozoítos de *E. histolytica* com hemácias: **50 mg/kg/dia** em 3 doses, **10 dias** [MS]
Metronidazol: giardíase	Só com indicação	Diarreia ≥ 14 dias com cistos ou trofozoítos: **15 mg/kg/dia** em 3 doses, **5 dias** [MS]
Probióticos	Divergência	SBP admite cepas específicas, que reduzem a diarreia em cerca de 1 dia: *S. boulardii* CNCM I-745 250–750 mg/dia, *L. rhamnosus* GG ≥ 10^{10} UFC/dia, 5–7 dias; *B. clausii* não [SBP]. A OMS sugere **não** usar [OMS]
Racecadotrila	Coadjuvante possível	Citada pela SBP com base na ESPGHAN [SBP]; o NICE a classifica entre os antidiarreicos e não recomenda [NICE]
Vitamina A	Grupos de risco	Reduz mortalidade em populações com alto risco de deficiência (desnutridos) [SBP]

Cai na prova · o que nunca fazer

- Antibiótico de rotina na diarreia aquosa (exceto cólera grave) ou na disenteria em bom estado geral.
- Antidiarreico (loperamida e afins) em criança.
- Refrigerante ou suco adoçado como reidratante.
- Suspender o aleitamento [MS].

Atenção · prevenção

Vacina contra rotavírus em dia, aleitamento materno, lavagem das mãos, água tratada e higiene dos alimentos [SBP] [MS]. A cobertura vacinal e a mortalidade por diarreia no Brasil caminham em sentidos opostos e se associam à vulnerabilidade social [SBP].

Capítulo VIII

O que mudou e onde as diretrizes divergem

Tabela 10 · *Cartaz do MS: antes × agora*

Ponto	Antes	Agora
Avaliação	Sem boca/língua e peso; pulso B "rápido, fraco"	Inclui boca e língua e perda de peso; pulso B "cheio"
Antiemético	Não usar	Ondansetrona dose única no Plano B se vômitos persistentes
Plano B sem melhora	—	Após 6 h, encaminhar para internação
Plano C, expansão	< 5 anos: SF 20 mL/kg em 30 min, repetir; ≥ 5 anos: 30 + 70 mL/kg	< 1 ano: 30 mL/kg/1 h + 70 mL/kg/5 h; ≥ 1 ano: 30 mL/kg/30 min + 70 mL/kg/2 h 30
Disenteria	Ciprofloxacino 15 mg/kg 12/12 h, 3 dias	Azitromicina até 30 kg; ciprofloxacino acima

[MS-ant] [MS] [SBP]

Tabela 11 · *MS × OMS × NICE*

Ponto	MS / SBP	OMS 2024	NICE
Zinco	10 mg (até 6 m) ou 20 mg/dia, 10–14 dias	**5 mg/dia** por 10–14 dias, até 10 anos	—
Probiótico	SBP: cepas específicas	Sugere não usar	—
Disenteria	Azitromicina até 30 kg	Antibiótico recomendado (ciprofloxacino)	—
Bolus no choque	Plano C por idade	—	10 mL/kg em < 10 min e reavaliar [NICE-L]

[MS] [SBP] [OMS] [NICE]. Prova brasileira: Ministério da Saúde.

Cai na prova · resumo do que é brasileiro

Quadro de 7 variáveis, planos A, B e C, zinco 10/20 mg, ondansetrona no Plano B, Plano C dividido em 1 ano, azitromicina na disenteria até 30 kg [MS].

Capítulo IX

Mapa de decisão e pegadinhas

1 · Avaliar	Estado geral, olhos, sede, lágrimas, boca, prega, pulso, peso. Na dúvida, o pior cenário.
2 · Plano A	Sem desidratação: líquidos após cada evacuação, alimentação habitual, zinco, sinais de alerta.
3 · Plano B	≥ 2 sinais: SRO 50–100 mL/kg em 4–6 h no serviço; ondansetrona se vômito persistente; gastróclise; 6 h sem melhora: internar.
4 · Plano C	≥ 2 sinais com 1 grave: < 1 a 30 mL/kg/1 h + 70/5 h; ≥ 1 a 30/30 min + 70/2 h 30; manutenção 4:1 + reposição 1:1 + KCl.
5 · Sangue	Com comprometimento geral: azitromicina (até 30 kg); < 3 m ou imunodeficiente: ceftriaxona; reavaliar em 48 h.
6 · Outros	> 14 dias: persistente; desnutrição grave: reidratar e referir; febre ≥ 39 °C: procurar outro foco.

Tabela 12 · *Pegadinhas de decisão*

Afirmação tentadora	Correção
Diarreia aguda pede antibiótico	Só disenteria com comprometimento geral ou cólera grave
Desidratado vai direto para a veia	Plano B oral; se não der, gastróclise; veia no Plano C, na falha enteral ou na piora
Suspender o leite	Manter alimentação habitual e aleitamento
Antiemético é proibido	Ondansetrona dose única no Plano B com vômitos persistentes
Plano C: 20 mL/kg em todo menor de 5 anos	Era o cartaz antigo; hoje divide em 1 ano
Ciprofloxacino na disenteria de criança de 4 anos	Azitromicina até 30 kg
Zinco é para todas as idades	Menores de 5 anos, 10–14 dias
Melhorou na veia, pode parar a SRO	Parar a veia só quando a SRO mantém a hidratação; observar 6 h

Capítulo X

Questões de estudo

1. Criança de 2 anos com diarreia há 2 dias: irritada, olhos fundos, sedenta, bebe avidamente, sem lágrimas, prega que desaparece lentamente, pulso cheio. A conduta é:

A Plano A em casa.
B Plano B: SRO 50–100 mL/kg em 4–6 h no serviço.
C Plano C endovenoso.
D Antibiótico e Plano A.

2. Lactente de 7 meses, 8 kg, letárgico, não consegue beber, pulso fraco, prega muito lenta. A fase de expansão pelo MS atual é:

A SF 20 mL/kg em 30 min, repetir até hidratar.
B 30 mL/kg em 1 h e 70 mL/kg em 5 h, com SF 0,9% ou Ringer lactato.
C 30 mL/kg em 30 min e 70 mL/kg em 2 h 30 min.
D SRO 100 mL/kg por sonda.

3. Menino de 4 anos, 16 kg, com diarreia com sangue, febre alta persistente e tenesmo, desidratado. O antibiótico pelo MS é:

A Ciprofloxacino 15 mg/kg de 12/12 h, 3 dias.
B Azitromicina 10 mg/kg no 1º dia e 5 mg/kg/dia por mais 4 dias.
C Metronidazol por 10 dias.
D Nenhum, só hidratar.

4. No Plano B, criança de 18 meses tem vômitos persistentes que atrapalham a SRO, sem sinais gerais de perigo nem piora. Pelo MS:

A Antiemético é contraindicado.
B Uma dose de ondansetrona pela idade e peso e manter a SRO.
C Passar direto ao Plano C.
D Suspender a SRO por 6 horas.

5. Sobre o zinco na diarreia aguda pelo MS:

A 5 mg/dia para todas as idades.
B 10 mg/dia até 6 meses e 20 mg/dia acima de 6 meses e abaixo de 5 anos, por 10–14 dias.
C Só na diarreia persistente.
D Não tem indicação.

6. Criança com diarreia em Plano B há 6 horas, sem melhora da desidratação. Deve-se:

A Liberar com SRO para casa.
B Encaminhar ao hospital de referência para internação.
C Iniciar loperamida.
D Manter o Plano B por mais 24 h.

Gabarito comentado

1 · B. Dois ou mais sinais sem asterisco: com desidratação, Plano B no serviço [MS].

2 · B. Desidratação grave em menor de 1 ano: 30 mL/kg em 1 h + 70 mL/kg em 5 h. A alternativa a é o cartaz antigo; a c, a faixa de 1 ano ou mais [MS].

3 · B. Disenteria com comprometimento geral, até 30 kg: azitromicina 5 dias [MS].

4 · B. Ondansetrona dose única no Plano B com vômitos persistentes, para permitir a reidratação oral [MS].

5 · B. Zinco do MS: 10 mg até 6 meses, 20 mg de > 6 meses a < 5 anos, 10–14 dias; os 5 mg são da OMS [MS] [OMS].

6 · B. Sem melhora após 6 h de Plano B: internar [MS].

Apêndice

Fontes e anotações

- [MS] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. *Manejo do paciente com diarreia: avaliação do estado de hidratação do paciente* (cartaz). Versão disponível no portal em out. 2026.
- [MS-ANT] BRASIL. Ministério da Saúde. *Manejo do paciente com diarreia* (cartaz, versão anterior, BVS).
- [SBP] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. DC de Gastroenterologia. *Diarreia aguda infecciosa*. Guia prático de atualização n.º 74, jun. 2023.
- [OMS] WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Guideline on management of pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years of age*, 2024.
- [NICE] NICE. *Diarrhoea and vomiting caused by gastroenteritis in under 5s* (CG84), texto completo. [NICE-L] NICE. *Intravenous fluid therapy in children* (NG29), atualização de out. 2022.
- [AIDPI] BRASIL. Ministério da Saúde; OPAS. *Manual de quadros de procedimentos: AIDPI Criança*, 2017.

Anotações